# PLAN VAN AANPAK 2024-2026

Regeling specifieke uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis

Gemeente Almere

**Datum:** 20 september 2023

**Coördinerend verantwoordelijk wethouder:** Froukje de Jonge

**Ambtelijke contactpersoon voor aanvullende informatie:** Jeanine Kuiperij–van der Veen
**E-mailadres:**
**Telefoonnummer:**

# Voorwoord

Je gezond voelen, controle over je eigen leven hebben en kunnen meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Almere wil een stad zijn waarin we een gezond en actief leven in de breedste zin stimuleren en beschermen. Waarin de kwaliteit van leven en de weerbaarheid van mensen groeit door sport, cultuur en sociale activiteiten. En waarin het mogelijk is voor jezelf en voor anderen te zorgen in een groene, aantrekkelijke omgeving. Dit zien we als het begin van de oplossing op veel terreinen, waaronder het groeiende zorginfarct. Niet voor niets hebben we positieve gezondheid in het coalitieakkoord 2022-2026 benoemd al een van de rode draden in ons handelen. Ook hebben we de ambitie uitgesproken om het medisch en sociaal domein veel meer met elkaar te verbinden.

**Landelijke aandacht**
We zijn blij dat er ook op regionaal en landelijk niveau veel aandacht is voor de genoemde thema's. Het Integraal Zorgakkoord (IZA) draagt bij aan stevige samenwerkingen om de focus te verleggen van zorg naar gezondheid en om een zorgtransformatie voor elkaar te krijgen. En het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) maakt versterkingen mogelijk van preventieve interventies die het dagelijks leven van mensen verbeteren en het zorgsysteem helpen ontlasten. Ook andere programma's leveren een bijdrage en ondersteunen dit gedachtegoed.

**Impulsen aan grotere bewegingen**
Dit plan van aanpak beschrijft hoe Almere de Brede specifieke uitkering (Brede SPUK) inzet die hoort bij de gemeentelijke preventietaken. Tot en met 2026 is er ruim € 12 miljoen beschikbaar voor onze stad, waarbij het deels gaat om nieuwe middelen. Hierdoor kunnen we lokaal en regionaal gerichte impulsen geven aan grotere bewegingen gericht op positieve gezondheid, een sterk sociaal fundament en het beteugelen van het zorginfarct. We willen hierbij niet alleen symptomen bestrijden, maar vooral ingrijpen in de kern van factoren die leiden tot gezondheidsverschillen.

**Meer samenhang en samenwerking**
De Brede SPUK draagt niet alleen bij aan inhoudelijke bewegingen. Het bevordert ook de samenhang en samenwerking voor een zo groot mogelijk effect. Het stimuleert om nog actiever verbindingen op te zoeken en na te gaan: wat kun je over en weer voor elkaar betekenen? Dat geldt binnen het sociaal domein én in de verbinding sociaal-fysiek.

**Versterken wat er is**
We streven er in Almere naar om zo min mogelijk nieuwe projecten en pilots op te starten via de Brede SPUK. Juist dat wat er is, versterken we gericht en duurzaam en daarbij blijven we leren en verbeteren. Dit betekent dat we bewezen interventies nastreven en blijven bijsturen op basis van actuele behoeften en praktijkervaringen. Werkt een interventie niet, dan durven we ermee te stoppen.

**Plan op hoofdlijnen**
Dit plan van aanpak is een plan op hoofdlijnen. De koers is helder en het proces is dat ook. Op veel onderdelen is verdere uitwerking nodig met de betrokken inwoners en professionals. Het plan laat daardoor deels specifieke interventies zien en deels procesvoorstellen om tot de inzet van passende interventies te komen. We denken hiermee een helder en eerlijk inzicht te bieden in het werk dat ons de komende jaren wacht. En het biedt de nodige flexibiliteit om processen al doende verder in te vullen met de mensen om wie het gaat.

# Inhoudsopgave


**1. Waar staat Almere? ..... 6**

1.1. Sterke bevolkingsgroei legt druk op voorzieningenniveau ..... 6

1.2. Oververtegenwoordiging (lagere) middenklasse leidt tot kwetsbaarheden ..... 7

1.3. Vergrijzing vraagt veel van zorgketen én sociale basis ..... 8

1.4. Langer zelfstandig thuis wonen leidt tot meer zorgen in jonge Almeerse wijken ..... 9

1.5. Personele krapte in de zorg vraagt om andere inrichting zorg- en welzijnsketen ..... 9

1.6. Dit is nodig: een duurzame, integrale en gezamenlijke inspanning ..... 10

1.7. Dit gebeurt er al: Almeers Preventieakkoord en Lokaal Sportakkoord Almere ..... 10

1.8. Dit gebeurt er ook al: bestaand beleid en aankomend beleid ..... 10

**2. Toelichting op aanvraag onderdelen regeling ..... 11**

**3. Aanpak hoofdthema's ..... 11**

3.1. Het laagdrempelig mogelijk maken van een gezond en actief leven ..... 13

3.2. Het voorkomen van zorgvragen ..... 17

3.3. Het ontlasten van de eerste lijn ..... 23

**4. Aanpak ondersteunende onderdelen ..... 24**

4.1. Versterken kennis- en adviesfunctie GGD ..... 25

4.2. Coördinatie van de regionale aanpak preventie ..... 26

**5. Bewaking voortgang ..... 26**

5.1. Organisatie ..... 26

5.2. Monitoring en effectmeting ..... 27

**6. Samenhang en synergie ..... 27**

**7. Verbinding onderdelen Brede SPUK en doelen GALA/Sportakkoord II ..... 28**

**8. Toestemming gebruik informatie ..... 30**

**9. Ondertekening ..... 31**

# 1. Waar staat Almere?

**De vraagstelling**
Beschrijf op hoofdlijnen de huidige situatie van sport, bewegen en cultuur en gezondheid en sociale basis. Doe dit aan de hand van relevante data en kennis over deze domeinen, zoals wijkprofielen, de gezondheidsmonitor, het regiobeeld etc.

- Geef een korte toelichting op de belangrijkste gezondheidsverschillen in de gemeente. Doe hetzelfde voor de verschillen in deelname aan sport, bewegen en cultuur.
- Wat zijn de belangrijkste opgaven op het gebied van sport, bewegen en cultuur?
- Wat zijn de belangrijkste opgaven op het gebied van gezondheid en sociale basis?
- Beschrijf ingeval van een reeds bestaand lokaal preventieakkoord of lokaal sportakkoord, met welke partijen en op welke wijze hieraan uitvoering is gegeven.

Om de huidige situatie van Almere op het gebied van sport en bewegen, cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en de sociale basis beter te begrijpen, brengen we in kaart wat de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen en opgaven zijn op deze thema's. Dit is de basis voor keuzes in de aanpak en interventies die verderop in dit plan staan beschreven.

## 1.1. Sterke bevolkingsgroei legt druk op voorzieningenniveau

In de nog korte ontstaansgeschiedenis is Almere uitgegroeid tot een stad van omvang (225.214 op 1 september 2023). Deze sterke bevolkingsgroei blijft doorzetten. Prognoses wijzen op een inwoneraantal van ruim 319.000 inwoners in 2050 (+42%).[1] Voorzieningen zijn lange tijd niet meegegroeid met de groei van de bevolking. Vooral in nieuwere delen van de stad (Almere Poort, Almere Hout) blijkt het lastig om voorzieningen van de grond te krijgen. Dit komt doordat budgetten voor onder andere sport, bewegen, cultuur, welzijn en preventie de groei van de stad niet automatisch volgen.

Op het gebied van sport, bewegen en cultuur is er behoefte aan goed toegankelijke locaties in de eigen woonomgeving. Een disbalans tussen behoeften en voorzieningen leidt er nu bijvoorbeeld toe dat ruim de helft (53%) van de cultuurbezoeken van jonge Almeerders plaatsvindt buiten de stad. De meest genoemde reden is dat het bezochte aanbod niet te vinden is in Almere zelf.[2]

In de hele stad is ook meer aandacht nodig voor laagdrempelige en aantrekkelijke ontmoetingsplekken, zowel binnen als in de openbare ruimte.[3] Die behoefte leeft bij inwoners en bij professionals. Bij ontmoeting in de openbare ruimte is er specifieke behoefte aan beweegvriendelijke, groene locaties met mogelijkheden voor verkoeling in de warme maanden.

De extremere temperaturen door klimaatverandering hebben een grote, directe invloed op de gezondheid van mensen. Ondanks het vele groen en water is er ook in Almere sprake van hitteproblematiek. Hittekaarten laten zien dat het groen niet gelijk verdeeld is over de stad. Dit kan verschillende delen van de stad minder aantrekkelijk maken om anderen te ontmoeten, te sporten en te bewegen in de openbare ruimte. GGD Flevoland en de gemeenten in de regio maken op dit moment samenwerkingsafspraken over het creëren van een gezonde leefomgeving.

[1] Bron: https://almere.incijfers.nl/dashboard/bevolking-3
[2] Bron: Gemeente Almere (2020), Cultuurparticipatiemonitor Almere.
[3] Bron: Movisie, Verwey-Jonker Instituut en Platform 31 (2023), 'Infosheet sociale staat van Almere'.

### 1.2. Oververtegenwoordiging (lagere) middenklasse leidt tot kwetsbaarheden

Delen van Almere kennen een oververtegenwoordiging van de (lagere) middenklasse. Mede hierdoor wijken inwoners op onder andere sportdeelname en gezondheid (fysiek en mentaal) gemiddeld negatief af van het landelijke beeld. Ook de cultuurdeelname is op onderdelen gedaald ten opzichte van eerdere jaren.

**Sportdeelname**

In Almere voldoet gemiddeld 43,4% van de inwoners aan de beweegrichtlijn. Dit is lager dan het landelijke niveau (50,5%). Ook het percentage lidmaatschappen bij sportverenigingen is veel lager dan landelijk (31,3% tegenover 48,2%). Dit is deels te verklaren door de populariteit van anders georganiseerd en individueel (buiten) sporten. Een kleine meerderheid van de Almeerders (59%) sport wekelijks. Ongeveer een derde (32%) sport niet. Hiervan is 42% laag opgeleid en 43% middel-hoog opgeleid.

Bijna vier op de tien niet-sporters (39%) willen wel sporten, maar ervaren drempels om dit te doen.[4] Denk hierbij aan beperkte tijd, gezondheidsklachten of een inkomen op minimumniveau. In 2023 kunnen maximaal 225 Almeerders met een laag inkomen en/of schulden via een intermediair een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. De inzet van het fonds is een pilot en er is op dit moment sprake van een wachtlijst.

Bij kinderen en jongeren spelen sociale en emotionele aspecten een grote rol om te (blijven) sporten: energie kwijtraken, een leuke activiteit hebben en zich goed voelen.[4] Kunnen sporten is niet in alle gezinnen vanzelfsprekend. We zien de afgelopen jaren dan ook een toename in aanvragen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

**Cultuurdeelname**

Ook niet alle Almeerders die dat willen, kunnen creatief bezig zijn. Een deel van de mensen (14%) geeft aan op een barrière te stuiten. Cursussen zijn te duur, er is onvoldoende diversiteit in het aanbod, er zijn geen oefenruimtes voor amateurs of er zijn te weinig beschikbare plekken. Onder Almeerse jongeren is een flinke afname te zien van deelname aan creatieve activiteiten. Iets meer dan de helft (55%) van de jongeren geeft aan in hun eigen vrije tijd iets kunstzinnigs of creatiefs te doen. In 2017 was dit nog 76%. Vier op de tien jongeren zeggen hier geen tijd (meer) voor te hebben, tegenover 29% in 2017. De kosten van activiteiten zijn voor 11% een reden om niet deel te nemen.[2]

**Gezondheid**

Almeerse kinderen hebben relatief vaker dan landelijk een minder goede start door vroeggeboorte en/of een laag geboortegewicht (175,8 per 1.000 baby's in 2021 ten opzichte van 152,8 landelijk).[5] Er is ook een hoger risico op blootstelling aan medische en/of sociale factoren, zoals stress, rook, slechte voeding of gebrek aan liefdevolle aandacht. Dit heeft een levenslang effect op de ontwikkeling. Verder is bekend dat instanties kinderen van ouders met psychische problemen (12% in Almere, tegenover 7% landelijk) of een verslaving (7% in Almere, gelijk aan landelijk) nog te vaak over het hoofd zien, terwijl deze kinderen een grotere kans lopen om ook klachten te ontwikkelen.[6]

---

[4] Bron: NOC*NSF (2022), Sportdeelnameonderzoek Almere.
[5] Bron: Perined (2021).
[6] Bron: Presentatie netwerkbijeenkomst KOPP/KOV Almere (2023): Ben ik in beeld?

Kijken we naar de leefstijl van Almeerse kinderen en jongeren, dan zien we dat 13% van de 5-jarigen en bijna 25% van de 10-jarigen (ernstig) overgewicht heeft. In heel Nederland is dit gemiddeld 16%. Kinderen die opgroeien met (ernstig) overgewicht leven minder lang in goede gezondheid en hebben meer kans op ziekten. Op jonge leeftijd heeft overgewicht bovendien een grote negatieve invloed op de psychische en sociale ontwikkeling. Almere heeft in juli 2023 het Pact met impact vernieuwd met veel zorg- en welzijnspartijen om overgewicht onder kinderen en jongeren te blijven aanpakken.[7]

Gegevens van GGD Flevoland laten zien dat Almeerders over de hele linie op veel indicatoren voor gezondheid slechter scoren dan het gemiddelde van Flevoland en Nederland.[7] Ruim de helft (55%) van de Almeerse volwassenen en ouderen heeft bijvoorbeeld overgewicht, tegenover 53% in Flevoland en 50% landelijk. Bij bijna een kwart (23%) gaat het om ernstig overgewicht, waar dat in Flevoland 20% is en in Nederland 16%. Dit maakt Almeerders extra kwetsbaar voor chronische aandoeningen.

De werkloosheid in Almere is structureel hoger dan landelijk en fluctueert sterker in tijden van economische neergang. Ook is de financiële (schulden)problematiek groot. Mede hierdoor telt de stad relatief veel kinderen die opgroeien in armoede, met name in eenoudergezinnen. Ook scheidingen komen in Almere relatief vaak voor. Bovendien bevinden veel Almeerders zich in een afhankelijke positie door onvoldoende aansluiting van voorzieningen, hulp en ondersteuning. Door al deze factoren liggen eenzaamheid en sociale uitsluiting op de loer.[8]

Wanneer stressfactoren als werkloosheid, armoede, schulden, eenzaamheid en sociale uitsluiting langdurig aanhouden, uit zich dit vaak in fysieke en mentale gezondheidsproblemen. In 2021 had 53% van de Almeerse jongvolwassenen psychische klachten en in 2022 56%. Bij volwassenen steeg het percentage met een matig tot hoog risico op een angststoornis of een depressie van 39% in 2009 naar 58% in 2022. In de leeftijdscategorie 18-34 jaar is dit risico zelfs 80% in 2022.[7] De stad kent daarnaast een bovengemiddeld huisartsenbezoek, terwijl er een fors en groeiend tekort is aan huisartsen. De huidige fysieke leefstijl en risicofactoren van veel Almeerders kunnen de vraag naar huisartsenzorg (en mogelijk ook specialistische vervolgzorg) verder opstuwen.

### 1.3. Vergrijzing vraagt veel van zorgketen én sociale basis

Druk op de zorgketen én de sociale basis ontstaat ook door de snel doorzettende vergrijzing in de stad. De jonge ouders die in de jaren '70, '80 en '90 naar Almere zijn getrokken, bereiken namelijk inmiddels massaal de pensioengerechtigde leeftijd. Zij hebben de levensfase bereikt dat men nauwelijks meer verhuist. Daarom voorziet Almere dat het aantal inwoners van 75 jaar en ouder gaat verdrievoudigen in de periode tot 2050: van 9.100 tot boven de 33.000. Alzheimer Nederland voorspelt bovendien dat het aantal Almeerders met dementie in de komende decennia gaat verviervoudigen: van 1.600 naar 6.700 in 2050.[9] Het aantal ouderen met een verhoogd valrisico neemt tot 2035 mogelijk al toe naar ruim 14.000 (tegenover 7.320 in 2020) met bijkomende geschatte jaarlijkse zorgkosten van € 20,4 miljoen.[10]

Deelname aan sport, bewegen en cultuur bevordert de vitaliteit en de sociale contacten van ouderen en het verkleint de risico's op vallen en dementie.[11] Ondanks de extra inzet vanuit onder andere

[7] Bron: GGD Flevoland, Gezondheidsmonitors Jeugd, Jongvolwassenen en Volwassenen en ouderen.
[8] Bron: Gemeente Almere, dashboards Onderzoek & Statistiek.
[9] Bron: Presentatie Flevoziekenhuis / ELAA, gedeeld op 17 februari 2023.
[10] Bron: VeiligheidNL (2020), Inwoners 65 jaar en ouder met verhoogd valrisico per gemeente 2020-2035.
[11] Bron: Gezondheidsraad (2017). Physical activity and risk of chronic diseases.

buurtsportcoaches sport maar 47% van de senioren wekelijks.[4] En in de leeftijd vanaf 65 jaar neemt 89% van de ouderen deel aan cultuuractiviteiten in tegenstelling tot 97% van de Almeerders van 18 tot en met 44 jaar.[2]

Ondanks de groei van de bevolking groeit het aantal Almeerse mantelzorgers niet. De komende decennia neemt het aantal potentiële beschikbare informele zorgverleners naar verwachting zelfs fors af. In Almere zijn er nu 25 keer zoveel 50- tot 65-jarigen als 85-plussers. In 2050 zijn dat er naar verwachting nog maar zes keer zoveel.[12]

We zien nu al een toename van mantelzorgers die zich tamelijk, zwaar of zelfs overbelast voelen. Onder de groep langdurig intensieve mantelzorgers zien we dat de groep die zelf al gepensioneerd is met 10% is toegenomen. Onder langdurig intensieve mantelzorgers ligt de meeste behoefte bij lotgenotencontact in de eigen wijk en het tijdelijk overdragen van zorgtaken. Dit aanbod is in Almere nog relatief beperkt en versnipperd georganiseerd. Kortdurende mantelzorgers hebben meer behoefte aan een reis- en onkostenvergoeding.[12]

Hoewel het Almeerse Expertisecentrum Mantelzorg veel mantelzorgers bijstaat, verdienen bepaalde groepen speciale aandacht. Jonge mantelzorgers zijn bijvoorbeeld het minst vaak op de hoogte van het ondersteuningsaanbod.[12] En net als landelijk zijn werkende mantelzorgers en mantelzorgers met een migratieachtergrond lastiger te bereiken. Het Expertisecentrum is er voor iedereen, maar focust zich op mensen die minder gemakkelijk zelf hun weg vinden in het beschikbare aanbod.

### 1.4. Langer zelfstandig thuis wonen leidt tot meer zorgen in jonge Almeerse wijken

Door uitstroom uit instellingen (beschermd wonen, maatschappelijke opvang, jeugdhulp met verblijf, etc.) neemt het aantal fysiek en mentaal kwetsbare inwoners in de wijk toe. Dit gebeurt in Almere tegen de achtergrond van een relatief jonge stad, waarin sociale buurtverbanden deels nog tot wasdom moeten komen en er een grote diversiteit is aan culturele achtergronden. Relatief veel Almeerders werken elders en voelen zich minder verbonden met hun woonstad.

Almere valt negatief op ten aanzien van sociale cohesie en vertrouwen in de medemens, de politiek en overheidsinstanties.[13] Als de gezondheid in de thuissituatie achteruitgaat, bestaat de kans dat juist deze groepen eerder en vaker een beroep gaan doen op zorg ondersteuning. Om dit te dempen is het juist in Almere belangrijk dat de stad sociale aspecten en gezondheidsfactoren in de toekomst nadrukkelijker meeweegt in het ontwerp van wijken (sociale stadsontwikkeling). In de achterliggende jaren is dit onderbelicht geweest.

### 1.5. Personele krapte in de zorg vraagt om andere inrichting zorg- en welzijnsketen

Een complicerende factor in de toenemende zorgbehoefte is de steeds krappere arbeidsmarkt. De bestaande tekorten aan zorg- en welzijnsprofessionals in Almere nemen alleen maar verder toe.[9] Verschuiving van taken binnen en tussen lijnen is nodig, maar geeft op korte termijn geen verlichting. Daarom moeten we mogelijkheden onderzoeken om anders en veel meer in samenhang te kijken naar de (personele) inrichting van de zorg- en welzijnsketen.

Een groot aandachtspunt hierbij is om professionals in sport en cultuur, sociaal werkers, vrijwilligers en mantelzorgers voldoende te erkennen, waarderen en toe te rusten en hen niet te overvragen in hun capaciteit, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Deze ontwikkeling benadrukt de noodzaak

[12] Bron: Gemeente Almere (2022), Almere in de peiling.
[13] Cuperus, R. en De Voogd, J. (2021), Atlas van afgehaakt Nederland.

om goed samen te werken bij de organisatie van (combinaties van) formele en informele vormen van ondersteuning, zodat we inwoners het juiste bieden op de juiste plek. En minstens zo belangrijk zijn de mogelijkheden voor inwoners om elkaar (laagdrempelig) te ontmoeten, zich te ontplooien, te ontspannen en elkaar te helpen.

### 1.6. Dit is nodig: een duurzame, integrale en gezamenlijke inspanning

Bovenstaande punten onderstrepen dat de gezondheid van Almeerders en de zorg- en welzijnsketen in Almere nu al onder druk staan. Door de sterke bevolkingsgroei, snelle vergrijzing, toename van (leefstijlgerelateerde) aandoeningen, het langer thuis wonen en arbeidsmarkttekorten neemt de druk op het zorgsysteem in Almere nog verder toe. Het sociaal domein kan die druk deels helpen verminderen. Maar ook hier zijn op dit moment al aanwijsbare knelpunten en we verwachten dat deze in de toekomst alleen nog maar toenemen. Hierbij moeten we het 'waterbedeffect' voorkomen. Een duurzame, integrale en gezamenlijke inspanning van partijen in de zorg- en welzijnsketen is daarom nodig, met aandacht voor preventie.

### 1.7. Dit gebeurt er al: Almeers Preventieakkoord en Lokaal Sportakkoord Almere

Op diverse manieren werkt Almere al aan het terugdringen van gezondheidsverschillen. Een goed voorbeeld hiervan is het Almeers Preventieakkoord. Dit is in 2021 gelanceerd en is een initiatief vanuit de gemeente samen met veel grote en kleine partijen in Almere. Enkele voorbeelden van partners zijn Eredivisie-voetbalclub Almere City FC, welzijnsorganisatie De Schoor, De Kinderkliniek, GGD Flevoland, het Flevoziekenhuis, Zilveren Kruis, Zorggroep Almere en Jongeren Almere Met Een Stem (JAMES). Met de initiatieven uit het akkoord dragen we bij aan voldoende bewegen, gezonde voeding, mentaal welbevinden, een rookvrije generatie en nauwere samenwerking tussen partners. Enkele voorbeelden van gerealiseerde initiatieven zijn de 'Moestuin Tussen de Vaarten', waarbij ouderen gezamenlijk tuinieren en koken en een initiatief waarbij een inwoner zich inzet om mentale gezondheid bespreekbaar te maken onder de Hindoestaanse bevolking.

Het motto van het Almeerse sportbeleid is: 'Almere de sportiefste stad van Nederland'. Het Lokaal Sportakkoord II (een actualisatie van een eerder akkoord uit 2018) is een samenwerking tussen gemeente, maatschappelijke organisaties, bedrijven en verenigingen. De kerngroep achter het Lokaal Sportakkoord II – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunt sportaanbieders en -verenigingen en maatschappelijke organisaties om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Dit is belangrijk in de individuele levens van mensen, maar ook voor de maatschappij als geheel. De Social Return On Investment van sporten en bewegen in Almere bedraagt namelijk 2,77. Wanneer in Almere 10% meer inwoners aan de beweegrichtlijn gaan voldoen, dan levert dit lokaal per jaar € 19.063.255 op.[14]

### 1.8. Dit gebeurt er ook al: bestaand beleid en aankomend beleid

Almere is ook op andere vlakken geen leeg canvas. Er is veel bestaand beleid dat raakt aan de thema's in de Brede SPUK, zoals het beleidsplan sociaal domein, de Almeerse sportvisie, het cultuurplan, het welzijnskader, de visie op de openbare ruimte en diverse uitvoeringsprogramma's.

De gemeente bereidt op dit moment een nieuwe nota gezondheidsbeleid, een groenkader, een klimaatadaptatiestrategie en een sociale werkagenda voor. Daarnaast ontwikkelen het preventief jeugdbeleid, het jongerenwerk en de wijkteams zich verder. Ook neemt de gemeente actief deel aan het regionale netwerk Positief Gezond Almere, het vehikel om de zorgtransformatie in Almere mee

[14] Kenniscentrum Sport en Bewegen (2023), Infographic Maatschappelijke waarde sport en bewegen Almere.

vorm te geven via onder meer het Integraal Zorgakkoord. Verder zijn er verschillende lokale en regionale netwerken op andere thema's. Op alle thema's zijn de gemeente, maatschappelijke organisaties en andere betrokkenen doordrongen van noodzaak om over domeingrenzen heen te kijken om het verschil te kunnen maken in de grote maatschappelijke opgaven die er zijn (zie ook hoofdstuk 6).

## 2. Toelichting op aanvraag onderdelen regeling

**De vraagstelling**
Als door de gemeente voor een of meer onderdelen geen aanvraag is ingediend, geef dan hier aan wat de reden daarvoor is.

De gemeente Almere heeft een aanvraag ingediend op alle vijftien onderdelen van de Brede SPUK 2023-2026. Dit geeft ons namelijk de meeste slagkracht om extra impulsen te geven aan de aanpak van de beschreven opgaven uit hoofdstuk 1. Hoe dit precies vorm krijgt, schetsen we in de volgende hoofdstukken.

## 3. Aanpak hoofdthema's

**De vraagstelling**
A. Wat wil de gemeente bereiken? (doelen en resultaten)

- Licht kort toe welke doelen en resultaten worden nagestreefd. Besteed daarbij, voor zover relevant, aandacht aan de doelen en resultaten die in het Hoofdlijnen Sportakkoord II en in het Gezond en Actief Leven Akkoord en de bijbehorende addenda zijn opgenomen.
- Licht toe op welke wijze preventie en positieve gezondheid nagestreefd worden en op welke wijze gezondheidsverschillen verkleind zullen worden.
- Verwijs daarbij waar mogelijk naar bestaande lokale (regionale) akkoorden, nota's, beleids- of uitvoeringsplannen.

B. Wat gaat de gemeente daarvoor doen? (uitvoering en samenwerking)

- Op welke doelgroep(en) wordt specifiek ingezet? Waarom?
- Hoe zijn (worden) deze doelgroepen betrokken bij de planvorming?
- Denk na over de schaalgrootte (wijk/kern, lokaal, regionaal). Zijn er wijken (kernen) aangewezen waar via deze regeling extra op wordt ingezet? Zo ja, welke wijken en waarom? Zo nee, waarom niet?
- Welke activiteiten of interventies gaat de gemeente inzetten en waarom?
- Hoe is de globale fasering (wat vindt plaats in de jaren 2024, 2025 c.q. 2026)?
- Beschrijf met welke partijen en op welke wijze wordt samengewerkt. Maar daarbij een onderscheid tussen lokale en regionale (c.q. provinciale) samenwerkingsverbanden.
- Benoem, indien passend, de reeds aanwezige netwerkstructuren zoals omschreven in het IZA. Tip: breng de verschillende coördinatoren voor het Sportakkoord II, GALA, IZA en de lokale preventieakkoorden en andere programma's in verbinding met elkaar, bijvoorbeeld in een vast kernteam.

Sport, bewegen en cultuur (doelen en resultaten, uitvoering en samenwerking)
Licht ook de inzet van functionarissen vanuit het onderdeel Brede Regeling Combinatiefuncties toe.

De gemeente Almere onderschrijft het hoofddoel van GALA (een gezonde generatie in 2040) en de doelen van het Sportakkoord II. De nog vast te stellen gemeentelijke nota Gezondheidsbeleid 2023-2026 bevat twee ambities om die gezonde generatie dichterbij te brengen:

- Het verkleinen van gezondheidsverschillen
- Het bieden van de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek

Deze ambities zijn in lijn met andere, eerder vastgestelde beleidsnota's. De Brede SPUK maakt gerichte interventies op dit vlak mogelijk in de lokale sociale infrastructuur en de leefomgeving. In het voorwoord hebben we al uitgesproken te streven naar het versterken van bestaande, grotere bewegingen. Voor maximale synergie clusteren we de bestedingen in de komende jaren dan ook rond drie centrale doelen:

1. Het laagdrempelig mogelijk maken van een gezond en actief leven
2. Het voorkomen van zorgvragen
3. Het ontlasten van de eerste lijn

Het geldende beleid, waar we onze keuze op baseren, is tot stand gekomen in samenspraak en samenwerking met (vertegenwoordigers van) de doelgroepen. Dat is één manier waarop de stem van de Almeerders is vertegenwoordigd in de koers van dit plan van aanpak. De korte tijd tussen de publicatie van de Brede SPUK-regeling en de indiendatum van dit plan van aanpak gaf beperkte ruimte voor uitgebreide aanvullende inwonerparticipatie. Wel is er een meedenkmarkt georganiseerd waar ideeën zijn getoetst bij maatschappelijke organisaties en cliënt- en patiëntvertegenwoordigers.

In het voorwoord op pagina 3 gaven we aan dat dit plan van aanpak deels specifieke interventies bevat en deels procesvoorstellen beschrijft om tot de inzet van passende interventies te komen. Dit biedt de nodige flexibiliteit om keuzes al doende verder in te vullen met de mensen om wie het gaat. Verder zijn de behoeften en ervaringen van Almeerders de belangrijkste graadmeters bij eventuele tussentijdse bijsturingen. Deze halen we op via onder andere uitvoerende professionals in de wijken, via evaluaties, (tevredenheids)onderzoeken en andere monitoringsinstrumenten en via inwoneradviesorganen als de Adviesraad Sociaal Domein en het Breed Overleg Plus. We vinden het essentieel dat inwoners een rol hebben bij alle afzonderlijke onderdelen van dit plan van aanpak. Maar zeker ook in het totaal van de grotere bewegingen die we nastreven in Almere.

In de rest van dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de uitvoering van de programma's in de Brede SPUK concentreren rond de drie genoemde doelen. Hierbij laten we zien op welke specifieke gebieden en/of groepen Almeerders we ons richten, welke onderliggende doelen we nastreven en welke resultaten per jaar dit oplevert.

### 3.1. Het laagdrempelig mogelijk maken van een gezond en actief leven

Elke Almeerder moet de mogelijkheid hebben om een gezond en actief leven te leiden in de stad. Daarom versterken we de groene, gezonde leefomgeving die aanzet tot bewegen en ontmoeten. We zorgen ook voor voldoende sport-, cultuur- en ontmoetingsactiviteiten die toegankelijk zijn voor alle inwoners. We hebben hierbij specifieke aandacht voor inwoners die minder vaak gebruik (kunnen) maken van het aanbod. Bijvoorbeeld door (financiële) drempels voor deelname weg te nemen. Daarnaast werken we aan bewustwording en stimulering van een gezond en actief leven. Ook door de presentie van sport-, cultuur- en welzijnsprofessionals in de wijken te versterken.

### 3.1.1. Leefomgeving

Er is al veel bestaand (of binnenkort vast te stellen) beleid voor het versterken van de sociale en gezonde leefomgeving. Denk aan de visie openbare ruimte, de Almeerse klimaatadaptatiestrategie, het groen-, bomen-, speel- en fietsbeleid, het actieplan geluid en het Schone Lucht Akkoord. De Brede SPUK biedt een kans voor kleine, gerichte ingrepen, merkbaar in de stad.

**(Proces)doelen**

- Het vergroenen en hittebestendig maken van speelplekken en schoolpleinen.
- De ontmoetingsfunctie versterken van deze groene en hittebestendige locaties.

**Doelgroep**

Kinderen, hun ouders en senioren in wijken waar het groot onderhoud nog lang op zich laat wachten en/of waar de hitteproblematiek het grootst is.

**Resultaten per jaar**

2023/2024/2025

- In 2023 stellen we een plan op voor het vergroenen van speel- en/of ontmoetingsplekken in 2024 en 2025. De gemeente werft uitvoerende partijen en legt (project)afspraken vast.
- In 2024 en 2025 streven we naar het vergroenen van verschillende speelplekken (centrale speeltuinen of schoolpleinen) om bescherming te bieden tegen uv-straling en hittestress te voorkomen. Op de speelplekken zijn ook andere voorzieningen geplaatst (bijvoorbeeld bankjes, watertappunten), om ontmoeting en beweging op deze koelteplekken te bevorderen.
- Waar mogelijk bevorderen en faciliteren we in alle drie de projectjaren initiatieven uit de stad om aanvullende (ontmoetings)locaties te vergroenen en hittebestendig te maken.

### 3.1.2. Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties

Sporten, bewegen en cultuurparticipatie zijn belangrijke elementen om je vitaal en gezond te voelen. We zien het ook steeds vaker als middelen om te activeren, om mentale en fysieke gezondheid te verbeteren, om eenzaamheid te bestrijden en sociale cohesie te bevorderen. Almere heeft de ambitie om te werken aan de 'gezondste generatie in 2040'. Sporten, bewegen en cultuurdeelname moeten zoveel mogelijk een vanzelfsprekend onderdeel zijn van de leefstijl van Almeerders.

Almere neemt sinds 2009 deel aan de Brede Regeling Combinatiefuncties. Alle middelen zijn ingezet via subsidies en een aanbesteding voor de inzet van buurtsportteams, kinderopbouwwerkers en cultuurcoaches. In 2023 heeft Almere het Lokaal Sportakkoord geactualiseerd.

**(Proces)doelen Lokaal Sportakkoord II**

- Het leggen van sterkere verbindingen tussen sport en cultuur en andere programma's/ domeinen.
- Het versterken van het fundament van sport: komen tot een robuust sportstelsel en een veilige, inclusieve en positieve sportcultuur die beter meegaat in maatschappelijke ontwikkelingen en die sterk genoeg is om nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden (voorwaarden op orde).
- Het vergroten van het bereik van sport: sporters, toeschouwers en vrijwilligers ervaren geen drempels en vinden een passend aanbod in de stad.
- Het vergroten van de betekenis van sport en de waarde van (top)sport en sportief bewegen, zowel emotioneel als maatschappelijk (bestrijden eenzaamheid, bevorderen kansengelijkheid).
- Het ondersteunen van gezonde en actieve initiatieven en het verkennen van het samenvoegen van de uitvoering met die van het Almeers Preventieakkoord.

**(Proces)doelen Brede Regeling Combinatiefuncties**

- Het inzetten van buurtsport- en cultuurcoaches in de hele stad.
- Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur.
- Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur, waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld zijn.
- Het versterken van de samenwerking tussen sport, bewegen en cultuur en andere domeinen en programma's (onderwijs, zorg, welzijn, armoede en schulden).

**Doelgroep**

- Alle Almeerders (op basis van de vraag en behoefte), met oog voor kwetsbare groepen en mensen die achterblijven in hun sport-, beweeg- en cultuurdeelname. De cultuurcoaches richten zich hierbij specifiek op kinderen en jongeren (4-14 jaar) via het buitenschoolse aanbod.
- Sportverenigingen en sportaanbieders.

**Resultaten per jaar**

2023: Lokaal Sportakkoord II

- Er is een kick-off georganiseerd voor en met alle sportaanbieders.
- Er is een commerciële sportaanbieder toegevoegd aan de kerngroep voor het Lokaal Sportakkoord II en de toevoeging van een maatschappelijke zorgpartner is verkend.
- Er is verkend of de ondersteuning van gezonde en actieve initiatieven is samen te voegen met het Lokaal Preventieakkoord.
- Er is een coördinator sport en preventie aangesteld.
- Er is een klankbordgroep opgericht.
- Er is een pilot gestart met clubkadercoaching.
- De toegang tot ondersteuning voor sportaanbieders is verbeterd volgens de éénloketgedachte.
- Sportaanbieders zijn geïnformeerd over de Sportservices van NOC*NSF.
- Er is een communicatiecampagne gestart rond sport, bewegen en gezondheid.

2024: Lokaal Sportakkoord II

- De acties uit het Lokaal Sportakkoord II zijn voortgezet.
- De pilot met clubkadercoaching is geëvalueerd en is voortgezet na verwerking van de aandachtspunten.

2023: Brede Regeling Combinatiefuncties

- Er zijn buurtsportcoaches en cultuurcoaches structureel actief in de hele stad.
- Er is verkend welke rol buurtsportcoaches en cultuurcoaches kunnen spelen bij de uitvoering van andere programma's van de Brede SPUK (sport en cultuur als middel).
- Het gratis naschoolse aanbod van het Almere Kenniscentrum Talent (AKT) is voortgezet.
- Er is verkend of uitbreiding van het AKT-programma KidsXtra met fysiotherapeuten mogelijk is.
- De inzet van de combinatiefunctionarissen in het voortgezet onderwijs is herijkt.

2024: Brede Regeling Combinatiefuncties

- Er is verkend welke rol cultuuraanbieders en het lokale Cultuurfonds kunnen hebben binnen het Lokaal Sportakkoord II en er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen.
- Er zijn vier nieuwe buurtsportteams gestart aan hun opdracht tot en met 2026.
- Er zijn een buurtsportcoach Gezondheid en Preventie en een buurtsportcoach Inclusief Sporten aangesteld die allebei stadsbreed actief zijn.
- Er is een Ondersteuningsroute Gezond Gewicht ingevoerd samen met vakdocenten lichamelijke opvoeding en de buurtsportteams (zie ook paragraaf 3.2.3).

2025-2026

- Er is verkend in hoeverre een uitbreiding van de doelgroep van de Cultuurcoaches haalbaar en wenselijk is.
- Alle eerder ingezette acties en de zichtbaarheid daarvan in de stad zijn voortgezet.

### 3.1.3. Terugdringen gezondheidsachterstanden

Een gezond en actief leven leiden is niet voor alle Almeerders vanzelfsprekend. Gezondheidsachterstanden zijn namelijk een hardnekkig probleem. De oorzaak ligt vaak in de sociaal-economische situatie van mensen. Dit betekent dat inkomen en opleidingsniveau factoren zijn die in grote mate bepalen of iemand meer of minder gezonde keuzes maakt. Om hier iets aan te doen, is er een gedifferentieerde aanpak nodig vanuit meerdere beleidsterreinen.

**(Proces)doelen**

- Het geven van brede aandacht aan stress door financiële problemen.
- Het verbeteren van de toegang en het wegnemen van drempels voor deelname van kinderen en volwassenen aan preventieve activiteiten (welzijn, onderwijs, sport, cultuur).
- Het structureel voortzetten van het Volwassenenfonds Sport & Cultuur na de pilotfase.
- Het leggen van verbindingen met de lokale coalitie Kansrijke start (zie paragraaf 3.2.1).

**Doelgroep**

Inwoners met een lage sociaal-economische status (SES), ofwel mensen met vooral een lage opleiding en/of een laag inkomen.

**Resultaten per jaar**

2023

- Samen met vertegenwoordigers van de doelgroep en maatschappelijke organisaties is er een plan gemaakt voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden.
- Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen om het plan gefaseerd uit te voeren. Waar mogelijk zijn 'quick wins' al in de praktijk gebracht.
- Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur is geëvalueerd en voortgezet.
- Er is een verkenning gedaan naar voortzetting van het Almeers Preventieakkoord om Almeerders te bereiken via lokale initiatieven en het mogelijk samenvoegen van de uitvoering met het Lokaal Sportakkoord II.
- Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben het onderzoek 'Positieve Gezondheidsvaardigheden' uitgevoerd met kwetsbare inwoners in Almere Haven en Poort. Via leernetwerken is er ook een verbinding gelegd met de inrichting van de openbare ruimte en wat inwoners hiervoor nodig hebben.
- Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben een participatieve evaluatie uitgevoerd van de lerende integrale aanpak GLOW! (Gezonde Leefomgeving Op Wijkniveau) in Almere Haven en Poort. Ook is deelname verkend aan effectiviteitsonderzoek.
- Er is een verkenning gedaan naar deelname aan het initiatief Gelijk Gezond, gericht op verbetering van de gezondheidssituatie van mensen met een minimuminkomen (doelgroep collectieve ziektekostenpolis voor inwoners met een laag inkomen).

2024/2025/2026

- De gekozen interventies voor het terugdringen van gezondheidsachterstanden zijn uitgevoerd en zijn voldoende vindbaar en toegankelijk voor de doelgroep.
- Via bestaande monitoringskanalen zijn de ervaringen en tevredenheid van inwoners in beeld en vindt er waar nodig bijsturing plaats op basis van de dagelijkse praktijk.

## 3.2. Het voorkomen van zorgvragen

Elke Almeerder krijgt op enig moment te maken met zorgvragen. Met gerichte inzet kunnen we waar mogelijk voorkomen dat bepaalde vragen ontstaan of verergeren. Zo dragen we bij aan de gezondheid en de kwaliteit van leven van inwoners en verminderen we de druk op de zorg. Het voorkomen van zorgvragen kan alleen als we effectief samenwerken binnen de Almeerse sociale infrastructuur. Sport en cultuur kunnen hierbij fungeren als preventieve middelen.

### 3.2.1. Kansrijke start

Sinds 2019 doet Almere mee aan het Actieprogramma Kansrijke Start en is er een lokale coalitie actief. Er liggen kansen om nog meer gezondheidsachterstanden en zorgvragen te voorkomen door aanvullende bewezen interventies in te zetten en de regionale samenwerking te versterken.

**(Proces)doelen**

- Het versterken, uitbouwen en structureel verankeren van de lokale coalitie in een ketenaanpak.
- Het maken van regionale samenwerkingsafspraken in de regio Flevoland.
- Het uitbouwen van interventies op een manier die past bij de Almeerse situatie en bij de behoeften van jonge gezinnen in een kwetsbare positie. We bouwen de interventies op aan de hand van drie actielijnen: voor, tijdens en na de zwangerschap. Hierbij hebben we waar mogelijk ook aandacht voor het bevorderen van de vitaliteit van de doelgroep via ontmoeting, sport, bewegen en cultuurparticipatie.

**Doelgroep**

(Aanstaande) ouders en hun kinderen in de leeftijd van –9 maanden tot circa 2 jaar. In het bijzonder: kwetsbare gezinnen en kinderen geboren in kwetsbare leefomstandigheden in de hele stad. De kwetsbaarheid komt voort uit een combinatie van factoren: psychiatrische problemen, huiselijk geweld, een verstandelijke beperking, verslaving, armoede en schulden, dakloosheid, problemen met loverboys of illegaliteit.

**Resultaten per jaar**

2023

- De lokale coalitie Kansrijke start (netwerk, stuurgroep, communicatie-inzet) is voortgezet.
- Er hebben gerichte trainingen en scholing voor professionals plaatsgevonden.
- Er zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt over een ketenaanpak.
- Er is een start gemaakt met het uitbouwen van interventies:
  - voor de zwangerschap: voorkomen van (herhaalde/kwetsbare) onbedoelde zwangerschap
  - tijdens de zwangerschap: passende voorlichting, samenwerking tussen professionals
  - na de zwangerschap: tijdig signaleren problemen, versterken, verbreden en beter benutten ondersteuningsaanbod

2024/2025/2026

- De regionale samenwerking en de interventies zijn verder uitgebouwd en versterkt.
- Er is een effectmeting en evaluatie uitgevoerd.

### 3.2.2. Opgroeien in een kansrijke omgeving en vroegsignalering alcoholproblematiek

Hoe eerder en hoe meer jongeren alcohol en andere middelen gebruiken, hoe groter de kans op problemen en zorgvragen later in het leven. Vroegsignalering is belangrijk om persoonlijke en sociale schade te voorkomen of te verhelpen. Almere werkt hier al aan via bijvoorbeeld het lokale gezondheids- en verslavingsbeleid en het Preventie- en handhavingsplan alcohol. Een groep die vaak buiten

beeld blijft totdat de situatie escaleert, zijn kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving (zie paragraaf 1.2).

**(Proces)doelen**
- Het versterken van de netwerksamenwerking rond kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving en het ondersteunen van deze doelgroep.
- Het verkennen van de optie om de aanpak Opgroeien in een kansrijke omgeving op te zetten. De scope raakt ook thema's als mentale gezondheid, de sociale basis en fysieke leefomgeving.

**Doelgroep**
- Kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving.
- Jongeren van 10 tot 18 jaar.

**Resultaten per jaar**
2023
- Er zijn procesafspraken gemaakt over hoe de netwerksamenwerking en ondersteuning rond kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving te verbeteren zijn.

2024
- De uitvoering van de procesafspraken rond kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving is gestart.
- De verkenning van de optie om de aanpak Opgroeien in een kansrijke omgeving op te zetten is afgerond en de vervolgstappen zijn in kaart gebracht.

2025/2026
- De netwerksamenwerking en ondersteuning rond kinderen van ouders met psychische problemen en/of een verslaving is versterkt. Er is in 2026 een effectmeting en evaluatie uitgevoerd.
- Afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning rond Opgroeien in een kansrijke omgeving zijn de vervolgstappen in gang gezet en geëvalueerd op procesniveau.

### 3.2.3. Mentale gezondheid
De mentale gezondheid van Almeerders staat onder druk, vooral bij jongeren (zie paragraaf 1.2). Dit heeft een grote impact op de totale gezondheid(sbeleving). Het bevorderen van mentale weerbaarheid – in samenhang met het bredere gezondheidsbeleid - draagt eraan bij dat Almeerders beter in hun vel zitten en minder zorgvragen hebben.

Het Integraal Zorgakkoord regelt daarnaast dat er in elke regio herstelnetwerken en mentale gezondheidscentra komen. Deze bevorderen de samenwerking tussen het sociaal domein, huisartsen en de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook helpen ze om de wachtlijsten voor de ggz te verkleinen.

**(Proces)doelen**
- Het bewustzijn over mentale gezondheid te vergroten, bijvoorbeeld via campagnes.
- Het kiezen van één kansrijke en/of bewezen effectieve interventie die het beste past bij de Almeerse situatie en bij de behoeften van jongeren en jongvolwassenen.
- Het mentaal welbevinden een stevige plek geven in de aanpak van een gezonde leefstijl.
- Het mentaal welbevinden verankeren in andere beleidsterreinen (mental health in all policies).
- Het inrichten van herstelnetwerken (via IZA).
- Het inrichten van mentale gezondheidscentra (via IZA).

**Doelgroep**
Jongeren en jongvolwassenen (12-27 jaar) in wijken waar de problematiek rondom mentale gezondheid het grootst is.

**Resultaten per jaar**
2023
- De gemeente en GGD Flevoland hebben in kaart gebracht in welke Almeerse wijken de mentale problematiek van jongeren en jongvolwassenen het grootst is.
- De gemeente en GGD Flevoland hebben met jongeren en jongvolwassenen doorgepraat over de opbrengsten van eerdere gesprekstafels met jongerenwerkers, straatwerkers, buurtsportcoaches en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, de gezondheidszorg, het onderwijs en andere maatschappelijke organisaties.
- De keuze voor de meest passende interventie is afgerond.

2024
- De inkoop van de gekozen interventie is afgerond en de uitvoering is gestart.
- De monitoring van de gekozen interventie is opgezet.
- Er zijn stappen gezet om het mentaal welbevinden een stevige plek geven in de aanpak van een gezonde leefstijl en om het te verankeren in andere beleidsterreinen. Er is geïnventariseerd welke aanvullende acties nog nodig zijn op dit vlak.
- Er is verkend of en hoe het Jeugdfonds Sport & Cultuur en het Volwassenenfonds Sport & Cultuur een bijdrage kunnen leveren aan de mentale gezondheid van jongvolwassenen.

2025/2026
- De cliëntervaringen en effecten van de gekozen interventie zijn geëvalueerd en er zijn aandachtspunten opgehaald voor het vervolg.

### 3.2.4. Aanpak overgewicht en obesitas
In Almere hebben zowel kinderen als volwassenen en ouderen vaker overgewicht en obesitas dan gemiddeld in de rest van Nederland (zie paragraaf 1.2). Dit maakt Almeerders extra kwetsbaar voor chronische aandoeningen. Het maken van meer gezonde keuzes in het leven, draagt eraan bij dat Almeerders zich beter voelen, dat gezondheidsverschillen verminderen en dat er minder zorgvragen ontstaan.

Tot nu toe is de aanpak voor kinderen gericht geweest op een aantal doelwijken. Deze is vormgegeven in het Pact met impact (zie ook paragraaf 1.2), dat liep van 2018 tot en met 2022. Het Pact is inmiddels verlengd voor de periode 2023-2026.

De komende jaren streven we naar een stedelijke ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht. Landelijk is het doel dat de zorgverzekeraars vanaf 2024 de kinder-GLI (gecombineerde leefstijlinterventie) en de Centrale Zorgverlener te financieren. Hier is goede afstemming over nodig. Voor volwassenen bestaat er al een GLI, maar nog geen ketenaanpak. De Preventiecoalitie Flevoland Gezond en Wel coördineert deze opgaven op regionaal niveau (zie ook paragraaf 4.2).

**(Proces)doelen**
- Het opzetten van een ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas.
- Het opzetten van een ketenaanpak in één stadsdeel, gekoppeld aan de GLI voor volwassenen, met gefaseerde uitbouw naar de rest van de stad.

**Doelgroep**
Kinderen en volwassenen met overgewicht en obesitas.

**Resultaten per jaar**
2023
- Er zijn voorbereidingen getroffen voor de beide ketenaanpakken:
  - Voor de ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht is in kaart gebracht wat nodig en haalbaar is voor de uitbreiding naar de hele stad.
  - Signalering en toeleiding van kinderen via de Ondersteuningsroute Gezond Gewicht zijn geïntroduceerd op alle scholen van de Almeerse Scholen Groep in het primair onderwijs.
  - Er zijn afspraken gemaakt met JGZ Almere over de Centrale Zorgverlener in 2024.
  - Voor de ketenaanpak voor volwassenen is het proces uitgewerkt.
- Er is binnen de regio Flevoland een heldere verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

2024
- De ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht is uitgebreid naar de hele stad.
- De ketenaanpak voor volwassenen heeft verder vorm gekregen.

2025/2026
- De ketenaanpak Kind naar Gezond Gewicht is in uitvoering in de hele stad. Er is in 2026 een effectmeting en evaluatie uitgevoerd.
- De ketenaanpak voor volwassenen is er sprake van een werkende keten die is geëvalueerd op procesniveau.

### 3.2.5. Versterken sociale basis
Almere heeft veel inwoners die zich betrokken voelen bij hun omgeving, die hun handen uit de mouwen kunnen en willen steken en die iets willen betekenen voor een ander. Die betrokkenheid willen we structureel stimuleren. We willen investeren in het 'wij' en in samenredzaamheid. Dit draagt bij aan de kwaliteit van leven van inwoners én aan het voorkomen van zorgvragen.

Het versterken van de sociale basis en algemene voorzieningen als laagdrempelige maatschappelijke ondersteuning gebeurt onder andere aan de hand van het welzijnskader 'WELzijn in Almere' (2021).

**(Proces)doelen**
- Het stimuleren van meer laagdrempelige ontmoetingsplekken, deels in samenhang met investeringen in de leefomgeving (zie paragraaf 3.1.1).
- Het versterken van de samenwerking tussen het welzijnswerk en sport, bewegen en cultuur als middelen voor ontmoeting en verbinding.
- Het omzien naar elkaar bevorderen door (zorg)vrijwilligers beter toe te rusten en samenwerking tussen informele en formele ondersteuning te stimuleren.
- Het gericht versterken van de sociale basis aan de hand van opbrengsten uit het programma en netwerk Positief Gezond Almere (zie paragraaf 1.8) en monitoring van de verwijzingen via Welzijn op Recept doen (zie paragraaf 3.3.1).

**Doelgroep**
Alle Almeerders, met aandacht voor risicogroepen.

**Resultaten per jaar**
2023
- Er is onderzocht welke onderdelen van de sociale basis extra versterking behoeven. Dit gebeurt op basis van signalen over het huidige gebruik van voorzieningen en analyses van de behoefte ten opzichte van het aanbod.
- Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen om deze versterkingen (waar nodig gefaseerd) uit te voeren. Waar mogelijk zijn 'quick wins' al in de praktijk gebracht.

2024/2025/2026
- De gekozen versterkingen van de sociale basis zijn uitgevoerd en zijn voldoende vindbaar en toegankelijk voor de doelgroep.
- De opbrengsten van het programma en netwerk Positief Gezond Almere en de monitoring van verwijzingen via Welzijn op Recept zijn vertaald naar gerichte aanvullende versterkingen van de sociale basis.
- De versterking van de samenwerking tussen het welzijnswerk en sport, bewegen en cultuur is zichtbaar en merkbaar voor inwoners in de stad.
- Via bestaande monitoringskanalen zijn de ervaringen en tevredenheid van inwoners in beeld en vindt er waar nodig bijsturing plaats op basis van de dagelijkse praktijk.

### 3.2.6. Mantelzorg
Ongeveer een kwart van de Almeerders is mantelzorger, waaronder ook veel kinderen en jongeren. Het aandeel mantelzorgers dat zich zwaar belast of overbelast voelt, stijgt. Het bieden van verlichting helpt om zorgvragen voorkomen.

**(Proces)doelen**
- Het nader onderzoeken van passende interventies op basis van eerder opgehaalde behoeften. Bijvoorbeeld op het gebied van lotgenotencontact, praktische hulp, (lichte) respijtzorg en de combinatie van mantelzorg en school of werk.
- Het implementeren van aanvullende vormen van mantelzorgondersteuning.

**Doelgroep**
Almeerders die intensief zorgen voor een naaste met een chronische ziekte, beperking, verslaving of psychische problemen. Er is speciale aandacht voor jonge mantelzorgers, werkende mantelzorgers en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Zij hebben vaak specifieke vragen/behoeften en zijn relatief lastiger te bereiken met het ondersteuningsaanbod.

**Resultaten per jaar**
2023
- Er is onderzocht via welke concrete interventies we het beste tegemoet kunnen komen aan de eerder opgehaalde behoeften van mantelzorgers.

2024/2025/2026
- Er zijn in 2024 afspraken gemaakt over de vervolgstappen om deze interventies (waar nodig gefaseerd) in de praktijk te brengen. Waar mogelijk zijn 'quick wins' al in de praktijk gebracht.
- De gekozen aanvullingen in het ondersteuningsaanbod van mantelzorgers zijn ingevoerd en zijn voldoende vindbaar en toegankelijk voor de doelgroep.
- Via bestaande monitoringskanalen zijn de ervaringen en tevredenheid van mantelzorgers in beeld en vindt er waar nodig bijsturing plaats op basis van de dagelijkse praktijk.

### 3.2.7. Eén tegen eenzaamheid

Veel Almeerders ervaren gevoelens van sociale eenzaamheid. Dit aandeel is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een lokale coalitie tegen eenzaamheid opgestart via de netwerkaanpak Goud in Almere (gericht op het ouderenbeleid), maar de activiteiten staan vooralsnog op een laag pitje. Het bestrijden van eenzaamheid kan veel zorgvragen voorkomen.

**(Proces)doelen**

- Het voortbouwen op de inzet van de netwerkaanpak Goud in Almere voor de lokale coalitie tegen eenzaamheid en het opstellen van een lokaal plan met deze coalitie.
- Het verkennen van de bijdrage van sport en cultuur als middelen om gevoelens van eenzaamheid te voorkomen en/of op te lossen.

**Doelgroep**

Almeerders van alle leeftijden die zich eenzaam voelen.

**Resultaten per jaar**

2023

- Met de leden van de eerder opgezette lokale coalitie is verkend hoe de activiteiten tegen eenzaamheid nieuw leven zijn in te blazen voor een bredere doelgroep. De lokale coalitie heeft een plan opgesteld met als pijlers:
  - het activeren van het netwerk
  - het aansluiten bij landelijke publiekscampagnes
  - aandacht voor en activiteiten in de landelijke Week tegen eenzaamheid
  - overige activiteiten en bijeenkomsten
- Er zijn afspraken gemaakt over de vervolgstappen om het plan in de praktijk te brengen. Waar mogelijk zijn 'quick wins' al in de praktijk gebracht.

2024/2025

- De beoogde activiteiten zijn ingevoerd en zijn voldoende toegankelijk voor de doelgroep.
- Via bestaande monitoringskanalen zijn de ervaringen en tevredenheid van inwoners in beeld en vindt er waar nodig bijsturing plaats op basis van de dagelijkse praktijk.
- Uiterlijk eind 2025 is in kaart gebracht hoe de bestrijding van eenzaamheid de aandacht blijft houden na het wegvallen van de rijksmiddelen.

### 3.2.8. Valpreventie

Valpreventie hangt sterk samen met thema's rondom het hebben en behouden van een gezond en actief leven. Bijvoorbeeld met bewegen, een gezonde leefstijl, mentaal welbevinden en sociale contacten. Deels is het een leefstijlaanpak en deels een (para)medische aanpak die veel zorgvragen en miljoenen per jaar aan zorgkosten kan voorkomen (zie ook paragraaf 1.3). Taken rond valpreventie zijn de verantwoordelijkheid van zorgverzekeraars en van de gemeente.

**(Proces)doelen**

- Het opzetten van een ketenaanpak om:
  - de samenwerking te verbeteren tussen het sociaal domein en (para)medici
  - valrisico beter te signaleren
  - mensen met een hoog valrisico beter te screenen en verder te helpen

- Het samen met (para)medici en de regionale ondersteuningsstructuur kiezen van één of meer bewezen interventies die het beste passen bij de Almeerse situatie en bij de behoeften van inwoners.
- Het lokaal invullen van de landelijke streefcijfers in het GALA, waarbij jaarlijks:
  - 14% van alle thuiswonende 65-plussers een risico-inschatting krijgt
  - 3% van alle thuiswonende 65-plussers met een verhoogd valrisico een erkende valpreventieve beweeginterventie volgt

**Doelgroep**
Thuiswonende 65-plussers.

**Resultaten per jaar**
2023
- Er zijn afspraken gemaakt over het opzetten van de ketenaanpak. Hiervoor hebben de gemeente, (para)medici en de regionale ondersteuningsstructuur in kaart gebracht:
  - welk aanbod ontbreekt in Almere, welke interventies we gaan inkopen en welke deskundigheidsbevordering hierbij nodig is
  - welke lokale of regionale maatregelen er nodig zijn voor zwaktes in de keten op het gebied van bijvoorbeeld signaleren, analyseren, toeleiden en gegevens uitwisselen
- Er is binnen de regio Flevoland een heldere verantwoordelijkheidsverdeling afgesproken tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

2024
- De ketenaanpak heeft verder vorm gekregen.
- De inkoop van de gekozen interventies is afgerond en de uitvoering is gestart.
- De monitoring van de ketenaanpak en de gekozen interventies is opgezet.

2025/2026
- De ketenaanpak is ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt om te blijven leren en verbeteren.
- De cliëntervaringen en effecten van de gekozen interventies zijn geëvalueerd en er zijn aandachtspunten opgehaald voor het vervolg.

## 3.3. Het ontlasten van de eerste lijn
Naast het voorkomen van zorgvragen moeten we ons ook richten op het verminderen van de druk op de eerstelijnszorg. Via het programma en netwerk Positief Gezond Almere (PGA, zie ook paragraaf 1.8) verstevigen we de verbindingen tussen het medisch en sociaal domein. In nauwe samenwerking met de Almeerse huisartsen komen we tot een plan voor minder consulten in hun spreekkamers. Naar schatting meldt 20% tot 40% van hun patiënten zich namelijk met niet-medische klachten.

### 3.3.1. Welzijn op Recept
Inzet van Welzijn op Recept in de gezondheidscentra draagt bij aan gerichte acties en doorverwijzingen van welzijnscoaches. In de wijken waar dit meerwaarde heeft, leggen we ook de verbinding met het project Financiën in de spreekkamer. Zo slaan we een brug tussen de huisartsenzorg en de aanpak van schulden en bieden we in de breedte de juiste ondersteuning op de juiste plek. We monitoren de verwijzingen van de welzijnscoaches nauwgezet. Zo weten we welke voorzieningen in het sociaal domein aanpassing of versterking behoeven om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek te kunnen bieden.

Het budget vanuit de Brede SPUK voor Welzijn op Recept is verre van toereikend. Vanwege de acute druk op de Almeerse huisartsenzorg doen we daarom via het PGA-programma en -netwerk ook een aanvraag voor budget uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

**(Proces)doelen**

- Het opzetten van een ketenaanpak met (zorg)professionals en de zorgverzekeraar.
- Het gefaseerd uitbreiden van Welzijn op Recept naar meer Almeerse wijken, in verbinding met Financiën in de spreekkamer waar dit relevant is.
- Het monitoren van de verwijzingen die de welzijnscoaches doen en het op basis hiervan gericht versterken van de voorzieningen in het sociaal domein.
- Het doen van een aanvraag uit het transformatiebudget van het Integraal Zorgakkoord via het programma en netwerk Positief Gezond Almere voor noodzakelijk aanvullend budget voor Welzijn op Recept.

**Doelgroep**

Almeerders met mentale en/of lichamelijke klachten met een niet-medische oorzaak.

**Resultaten per jaar**

2023

- Er zijn afspraken gemaakt over het opzetten van de ketenaanpak en voor het gefaseerd uitbreiden van Welzijn op Recept, waar relevant verbonden met de inzet van Financiën in de spreekkamer.
- Er zijn afspraken gemaakt met zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de bekostiging van Zorgdomein voor digitale terugkoppeling van de welzijnscoaches aan de huisartsen.
- Er zijn extra welzijnscoaches geworven. Zij hebben samen met de bestaande welzijnscoaches deskundigheidsbevordering doorlopen en zijn gestart met hun inzet.
- De monitoring van de verwijzingen van de welzijnscoaches is opgezet.
- Er een aanvraag ingediend voor het IZA-transformatiebudget.

2024

- De ketenaanpak en de gefaseerde uitbreiding van Welzijn op Recept en de verbinding met Financiën in de spreekkamer hebben verder vorm gekregen.
- De eerste gegevens uit de monitoring van verwijzingen zijn geanalyseerd en besproken met relevante organisaties.
- De effecten van de extra inzet van Welzijn op Recept zijn getoetst bij eerstelijnszorgverleners en er zijn aandachtspunten opgehaald voor het vervolg.

2025/2026

- De ketenaanpak en de gefaseerde uitbreiding van Welzijn op Recept en Financiën in de spreekkamer zijn ingevoerd. Er zijn afspraken gemaakt om te blijven leren en verbeteren.
- Voorzieningen in het sociaal domein zijn waar mogelijk gericht versterkt op basis van de analyses van verwijzingen. Waar dit nog niet mogelijk is gebleken, zijn er procesafspraken gemaakt, inclusief een prioritering en fasering.
- De effecten van de extra inzet van Welzijn op Recept zijn opnieuw getoetst bij eerstelijnszorgverleners en er zijn aandachtspunten opgehaald voor het vervolg.

## 4. Aanpak ondersteunende onderdelen

Twee onderdelen uit de Brede SPUK beleggen we rechtstreeks bij GGD Flevoland. Het gaat om het versterken van de kennis- en adviesfunctie van de GGD en coördinatie van de regionale aanpak preventie. De besluiten daartoe zijn genomen in het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein (BOSD) in Flevoland, een orgaan waarin de zes Flevolandse gemeenten bestuurlijk vertegenwoordigd zijn.

De hieronder beschreven doelen zijn geformuleerd op procesniveau en vergen nog een nadere uitwerking in concretere resultaten per jaar. Daarover maken we afspraken in het derde en vierde kwartaal van 2023.

### 4.1. Versterken kennis- en adviesfunctie GGD

Een stevige kennisbasis is belangrijk om nu en in de toekomst goed onderbouwde keuzes te kunnen maken voor lokale gezondheidsinterventies. De urgentie groeit nu delen van de zorg- en welzijnsketen, ook in Flevoland, steeds vaker vastlopen. Het significant verbeteren van de gezondheid van inwoners kan dit tij keren. Kennis, gezondheidsonderzoek en -data helpen gemeenten bij deze complexe opgave door het zicht op en begrip van de lokale gezondheidssituatie te vergroten.

**(Proces)doelen**

- GGD Flevoland brengt zijn adviserende en signalerende taak in lijn met de ontwikkelingen op het gebied van gezondheidsinterventies.
- GGD Flevoland groeit in zijn advisering mee met de steeds complexere kennis- en adviseringsbehoeften van gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
- GGD Flevoland versterkt zijn positie in bestaande kennisnetwerken waardoor landelijke kennisontwikkeling beter kan aansluiten op lokale behoeften.

**Resultaten**

- **Het versterken en verbreden van de kennis- en adviesfunctie:** adviseren vanuit een brede benadering van gezondheid – met meer oog voor de invloed van sociale en fysieke leefomstandigheden – vereist een bredere kennisbasis. GGD Flevoland zet bij de uitvoering van de eigen onderzoeks- en adviesfunctie meer in op het benutten van kennis uit verschillende disciplines. Het in samenhang beschouwen van kennis op verschillende leefdomeinen is essentieel om lokale gezondheidsontwikkelingen beter te duiden, oplossingen te zien en (toekomstige) risico's proactief te agenderen.
- **Het intensiveren van datagedreven werken en adviseren:** steeds meer organisaties in de zorg en publieke gezondheid verzamelen data. Ook GGD Flevoland beschikt over een rijkdom aan gegevens. In potentie zijn deze bronnen waardevol voor inzicht in de lokale gezondheidssituatie en het zorggebruik. Er liggen kansen om de GGD-data beter te benutten. Het koppelen van de GGD-bronnen aan externe databronnen is hierbij een nog op te lossen een knelpunt.
- **Het versterken van de brugfunctie in het landelijke kennisnetwerk:** de sturing op kennis en onderzoek in de publieke gezondheidszorg vindt vooral op landelijk niveau plaats. Door een intensievere samenwerking met kennisinstituten, academische werkplaatsen, universitaire medische centra, hogescholen en universiteiten versterkt GGD Flevoland de regionale kennisinfrastructuur. GGD Flevoland verbindt landelijke kennisontwikkeling aan lokale behoeften en laat lokale signalen stevig doorklinken in de landelijke (door)ontwikkeling van interventies. Deze brugfunctie is nodig om gemeenten interventies aan te kunnen reiken die passen bij, of op maat te maken zijn, voor hun lokale situatie.
- **Het verbeteren van het kennisproces:** GGD Flevoland verbindt zijn kennisopbouw steviger aan relevante gezondheidsvraagstukken en bestuurlijke speerpunten en sluit zo goed mogelijk aan bij de beleidscyclus van gemeenten. Het op het juiste moment aanbieden van kennis in alle fasen van

de beleidscyclus vergroot de doorwerking naar de (lokale) praktijk. Hiervoor stelt GGD Flevoland een kennisagenda op.

### 4.2. Coördinatie van de regionale aanpak preventie

Flevoland Gezond en Wel (FGW) heeft als Flevolandse preventiecoalitie de opdracht om de regionale ketenaanpakken te ondersteunen voor Kansrijke start (paragraaf 3.2.1), Kind naar Gezond Gewicht en de gecombineerde leefstijlinterventie voor volwassenen (paragraaf 3.2.4), valpreventie (paragraaf 3.2.8) en Welzijn op recept (paragraaf 3.3.1). Daarnaast is FGW betrokken bij het de werkgroep Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. FWG is een netwerk van zo'n twintig Flevolandse organisaties onder programmamanagement van de regionale ondersteuningsstructuren (ROS'en) Elaa en Proscoop.

**(Proces)doelen**

- Het ondersteunen van de opzet van regionale ketenaanpakken, met samenwerking en samenhang in de keten en zichtbare resultaten op proces- en effectniveau (regionale ondersteuning voor lokale uitvoering).
- Het vertalen van landelijke kennis naar de lokale situaties van de Flevolandse gemeenten.
- Het adviseren over vraagstukken op systeemniveau tussen gemeenten en zorgverzekeraars.

**Resultaten**

- **Themagroepen per preventieketen:** per preventieketen begeleiden een inhoudelijk projectleider en een procesbegeleider een themagroep. Er is regionale ondersteuning om tot een ketenaanpak te komen op basis van landelijke kennis en ervaringen uit andere regio's.
- **Deelname in werkgroep Samenwerking gemeente en zorgverzekeraars:** de voorzitter van FGW neemt deel aan de ambtelijke werkgroep Samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars.
- **Adviezen over systeemvraagstukken:** FGW adviseert over systeemvraagstukken die de ketenaanpakken in de weg zitten. De gemeenten en zorgverzekeraars bespreken deze in hun gezamenlijke bestuurlijke overleg.
- **Monitoring van het resultaat op proces en effect:** de inhoudelijk projectleider en procesbegeleider geven inzicht in de voortgang van de ketenaanpakken. Zij monitoren de effecten op de korte en langere termijn via bestaande indicatoren en data.

## 5. Bewaking voortgang

**De vraagstelling**
Licht toe hoe de voortgang van de uitvoering van het plan van aanpak wordt bijgehouden en hoe de bijsturing wordt georganiseerd

### 5.1. Organisatie

Het college van B en W heeft de coördinatie van de uitvoering van dit plan van aanpak belegd bij de gemeentelijke afdeling Zorg & Welzijn. De wethouder Gezondheid is de bestuurlijk opdrachtgever. Een programmaleider stuurt een kernteam en een bredere werkgroep aan met vertegenwoordigers van afdelingen uit het sociaal en fysiek domein.

De programmaleider is het eerste aanspreekpunt voor bestuur en management en bewaakt de betrokkenheid van in- en externe belanghebbenden bij de planvorming, uitvoering en evaluatie. Er is wekelijkse afstemming over de voortgang, over kruisbestuivingen tussen thema's en acties en over de

uitwisseling met inwoners en professionals. In een gezamenlijke werkagenda is per jaar terug te zien welke resultaten zijn afgesproken. Nu, aan de voorkant, zijn dat nog deels procesafspraken. Het verder inrichten van de uitvoering en monitoring gebeurt in de komende periode.

### 5.2. Monitoring en effectmeting

Veel van de gegevens uit de Almeerse situatieschets in hoofdstuk 1 zijn afkomstig uit reguliere periodieke onderzoeken door het gemeentelijke team Onderzoek & Statistiek en GGD Flevoland. Tijdens de uitvoering van dit plan van aanpak blijven dit belangrijke bronnen om het effect van de interventies te volgen. Deze data vullen we aan met meer specifieke monitoring door GGD Flevoland, Flevoland Gezond en Wel, de regionale ondersteuningsstructuur Elaa en uitvoerings- en ontwikkelorganisatie Flever. Verder is er in het kader van positieve gezondheid een onderzoek gestart onder de Almeerse bevolking. Dit onderzoek blijven we ook de komende jaren herhalen.

Het samenbrengen en duiden van data en inzichten is belangrijk om te zien in hoeverre we onze doelen en resultaten behalen. Hierbij beseffen we dat cijfers altijd maar een deel van de werkelijkheid weerspiegelen. Daarom vullen we deze aan met de praktijkervaringen en signalen van inwoners en professionals. We maken nog nadere afspraken om deze structureel op te halen en een plek te geven in (evaluatie)processen.

We beseffen verder dat de resultaten en effecten van dit plan van aanpak niet op zichzelf staan. Er vindt veel meer inzet op de beschreven thema's plaats dan alleen via de Brede SPUK. Het onderscheid in monitoring en effectmeting is waarschijnlijk niet altijd gemakkelijk of noodzakelijk om te maken. Het gaat om de grotere bewegingen en effecten in de Almeerse samenleving.

## 6. Samenhang en synergie

**De vraagstelling**
Beschrijf op welke wijze samenhang en synergie wordt nagestreefd tussen uitvoering op de verschillende hoofdthema's en onderdelen.

In Almere zijn we ons bewust dat geen enkele persoon of partij de opgaven in de stad alleen kan oplossen. Steeds meer weten we elkaar te vinden in netwerken over de grenzen van gemeentelijke afdelingen en inhoudelijke domeinen heen. Het programma en netwerk Positief Gezond Almere is daar een goed voorbeeld van. Niet vaak ging er zo'n brede coalitie van vertegenwoordigers van zorg(verzekeraars), welzijn, de Patiëntenfederatie en de gemeente aan het werk aan één grote gezamenlijke opgave. Het Pact met impact verbindt onderwijs, zorg, welzijn en sport rond het aanpakken van overgewicht en obesitas. Bij de recente aanbesteding van het buurtsportcoachwerk waren er percelen voor specifieke buurtsportcoaches Gezondheid en Preventie en Inclusief Sporten. En bij stedelijke vernieuwing en groot onderhoud zijn buurtbewoners, belangenorganisaties en ook sport, cultuur en gezondheid vertegenwoordigd in de planvorming en uitwerking. Dit zijn slechts enkele sprekende voorbeelden van een grotere beweging die gaande is.

Samenhang en synergie zijn deels te vangen in organisatie en werkafspraken. Maar ze hangen vooral af van de wil van bestuurders, professionals en andere betrokkenen om over hun (organisatie)belang en over de korte termijn heen te kijken. Uiteraard blijven organisaties ook gericht op hun eigen continuïteit. Daar hangt ook veel vanaf. Het gaat soms om grote werkgevers die zorgen voor stabiliteit in een stad als Almere.

Het regelmatig en georganiseerd met elkaar on tafel zitten op verschillende niveaus maakt stappen mogelijk in het bestendigen van de samenwerking. Dat geheel is nog niet af. Zo zouden inwoners nog meer betrokken kunnen zijn bij ontwikkelingen die hun woonomgeving en hun dagelijks leven raken. Belangenorganisaties vertegenwoordigen hun stem in processen, maar zij kunnen logischerwijs niet de grote diversiteit van de Almeerse bevolking bedienen. Ook kleinere organisaties en zzp'ers zitten niet vanzelfsprekend aan tafel, terwijl ook zij een wezenlijke rol spelen in de stad. Recht doen aan alle verschillende perspectieven en het samenbrengen van alle aanwezige betrokkenheid, kennis en ervaring in Almere is een vraagstuk voor de komende tijd. Een die de uitvoering van dit plan van aanpak overstijgt.

De gemeente Almere is partner bij het bereiken van de doelen en resultaten uit dit plan van aanpak, maar is niet per se of altijd trekker. Daar waar de ruimte er is, maakt de Brede SPUK impulsen mogelijk voor bredere bestaande bewegingen en interventies. Het meeste effect om een gezond en actief leven te bevorderen, zorgvragen te voorkomen en de zorgketen te ontlasten moet komen uit die grotere langetermijnveranderingen.

## 7. Verbinding onderdelen Brede SPUK en doelen GALA/Sportakkoord II

**De vraagstelling**
Vul a.u.b. onderstaande tabel in. Geef door het plaatsen van een vinkje (√) aan indien u met een onderdeel van de regeling een bijdrage levert aan specifieke doelen van het GALA of het Hoofdlijnen Sportakkoord II.

| | 1. Lokaal sportakkoord | 2. Brede regeling combinatiefuncties | 3. Terugdringen gezondheidsachterstanden | 4. Kansrijke Start | 5. Mentale gezondheid | 6. Aanpak overgewicht en obesitas | 7. Valpreventie | 8. Leefomgeving | 9. OKO & Vroegsignalering alcoholproblematiek | 10. Versterken sociale basis | 11. Mantelzorg | 12. Eén tegen eenzaamheid | 13. Welzijn op recept | 14. Versterking kennis- en adviesfunctie GGD | 15. Coördinatiekosten regionale aanpak preventie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Doelen Gezond en Actief Leven Akkoord** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terugdringen gezondheidsachterstanden | | √ | √ | √ | √ | √ | | | √ | √ | | | √ | | |
| Een gezonde fysieke leefomgeving die uitnodigt tot bewegen en ontmoeten | √ | √ | | | | | | √ | | | | | | | |
| Het versterken van (de verbinding met) de sociale basis | | √ | √ | | | | | | | √ | √ | √ | √ | | |
| Een gezonde leefstijl | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | | √ | √ | | | |
| Versterking van de mentale weerbaarheid en gezondheid | | √ | | √ | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | √ | | | |
| Vitaal ouder worden | √ | √ | | | | | √ | √ | | √ | √ | √ | √ | | |
| Domeinoverstijgende inzet vanuit een regionale preventie-infrastructuur | | | | √ | | √ | √ | | | | | | | √ | √ |
| **Doelen Hoofdlijnen Sportakkoord II** | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inclusie en diversiteit in de sport vergroten | √ | | √ | | | | | | | | | | | | |
| Sociaal veilige sport creëren | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| Vitale sportaanbieders: vergroten van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van het sportaanbod | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| Vaardig in bewegen: een leven lang sporten en bewegen voor ieder kind en iedere jongere | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| Ruimte voor sport en bewegen: een toekomstbestendige sportinfrastructuur | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| Maatschappelijke waarde van topsport optimaliseren | √ | | | | | | | | | | | | | | |
| **Doelen addendum BRC** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meer kinderen, jongeren en volwassenen die sporten, bewegen en meedoen aan cultuur (ook kwetsbare groepen die achterblijven in sport-, beweeg- en cultuurdeelname | √ | √ | √ | | | | | | | | | | | | |
| Sterke aanbieders in sport, bewegen en cultuur waarbij kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid geregeld is | √ | √ | | | | | | | | | | | | | |
| Een sterke verbinding tussen sport, bewegen en cultuur met andere domeinen en programma's (onderwijs, gezondheid, zorg, welzijn en sociale zaken/armoeden & schulden | √ | √ | | √ | | | | | | | | | | | |

## 8. Toestemming gebruik informatie

**De vraagstelling**
De gemeente geeft toestemming voor gebruik van de informatie uit het plan van aanpak voor de evaluatie van de landelijke samenwerkingsafspraken en de monitoring en doorontwikkeling van landelijk beleid.

√ De gemeente Almere verleent deze toestemming.

## 9. Ondertekening

**De vraagstelling**
Het plan van aanpak dient ondertekend te worden door ten minste één wethouder.

| | |
|---|---|
| Naam wethouder: | Froukje de Jonge |
| Portefeuille: | Werk en Inkomen, Armoede en Schulden, WMO en woon-zorgvoorzieningen, Asiel en Inburgering, Volksgezondheid. |
| Datum van ondertekening: | 26 september 2023 |
| Handtekening: | |